HagaZiekenhuis

Bronchoscopie Zoetermeer

Inleiding

Met u is een afspraak gemaakt voor een bronchoscopie.

Een bronchoscopie is een onderzoek waarbij met behulp van een dunne buigzame slang (scoop) de binnenzijde van de luchtwegen wordt bekeken. De slang heeft aan het eind een kleine camera en lichtbron. De scoop is aangesloten op een beeldscherm (monitor).

Door dit onderzoek krijgt de arts een goed beeld van de structuur van het slijmvlies van de long. Ook kan de arts eventuele ontstekingen en andere afwijkingen zien. Tijdens het onderzoek kunnen stukjes weefsel en slijm worden weggenomen of afgezogen. Dit wordt dan voor onderzoek opgestuurd.

Voorbereidingen op het onderzoek (risico bloedingen)

- Gebruikt u bloedverdunners: Ascal (carbasalaat, Acetylsalicylzuur), Sintrom (Acenocoumarol), Marcoumar (Fenprocoumon), Pradaxa (Dabigratran), Xarelto (Rivaroxaban), Elequis (Apixaban), Lixiana (Edoxaban), Brilique (Ticagleror), Plavix/Grepid (Clopidogrel) of Prasugrel.
  Uw behandelend arts bespreekt met u om het gebruik daarvan voorafgaand aan het onderzoek te stoppen.
- Zo nodig zal er op de dag van het onderzoek nog bloed afgenomen worden om te kijken of het bloed niet meer te dun is. Dit alles heeft te maken met het risico op bloedingen. Herstart van deze medicijnen verloopt ook in overleg met uw behandelend arts.
- Vanaf 6 uur voor het onderzoek mag u niet meer eten.
- Tot 2 uur voor het onderzoek mag u nog heldere dranken drinken. Dus geen melk en koffie. Bouillon is ook niet toegestaan vanaf 6 uur vóór bronchoscopie.
- Eventuele medicijnen mag u tot 2 uur voor het onderzoek innemen. ‘Puffers’ mogen tot vlak voor het onderzoek genomen worden.
- Het is voor u prettiger om geen knellende kleding te dragen.
- Er is een kans, dat u tijdens de scopie urine verliest. Neem daarom schone onderkleding mee.
- Wij vragen u geen parfum of eau de toilette te gebruiken. Dit in verband met een eventuele allergische reactie van de assisterende verpleegkundige.

Vóór het onderzoek

Vóór het onderzoek wordt met u en het hele team, nog een aantal vragen doorgesproken. Indien u geen Nederlands verstaat of spreekt, moet u zelf voor een begeleider zorgen die wel Nederlands verstaat en spreekt. Ook als u zich niet kunt uiten, bijvoorbeeld door afasie, wordt u verzocht iemand mee te nemen die voor u kan communiceren.

Sedatie

Als met u is afgesproken dat u in ‘slaap wordt gebracht’, wijken de regels iets af. Zie hiervoor de folder ‘sedatie’ . U wordt dan opgenomen op de endoscopie-uitslaapkamer en hier voorbereid. Hier komt u

na het onderzoek ook weer terug.

De (slaap)medicijnen die u heeft gekregen, kunnen uw reactievermogen beïnvloeden, óók als u zich goed voelt. Daarom is het noodzakelijk dat u door een begeleider naar huis wordt gebracht. Autorijden, fietsen of het besturen van een ander voertuig is na het onderzoek beslist niet toegestaan. Uw begeleider moet u vanaf de afdeling endoscopie komen ophalen. Neem die dag ook geen belangrijke beslissingen.

Het onderzoek

Het onderzoek duurt, inclusief de voorbereiding en de nazorg, ongeveer 45-60 minuten. Dit varieert per onderzoek. Als u een kunstgebit heeft, wordt u gevraagd dit uit te doen vlak voor de start van het onderzoek. Neem in dat geval zélf uw gebitsbakje mee van huis.

In de onderzoeksruimte krijgt u de verdoving. Uw keel en/of neus worden door middel van een spray en vloeistof verdoofd. Vooral de spray heeft een bittere smaak. Uiteindelijk wordt de keel gevoelloos. Hierdoor verloopt het onderzoek makkelijker. Door de verdoving voelt de keel dik aan. Dit is niet het geval maar alléén het gevoel. Er is genoeg ruimte voor de scoop. U kunt gewoon ademhalen.

In de onderzoeksruimte gaat u plat op uw rug liggen. Er wordt een ‘knijpertje’ op een van uw vingers gedaan. Hierdoor kan de verpleegkundige het zuurstofgehalte (saturatie) in uw bloed meten. Indien nodig krijgt u zuurstof via een slangetje in uw neus.

De scoop wordt ingebracht via uw neus of uw mond en gaat tussen de stembanden door naar de luchtpijp. Als de scoop via de mond wordt ingebracht, krijgt u een bitje tussen de tanden. Tijdens het onderzoek kunt u gewoon ademhalen. Vaak wordt slijm uit de mondholte weggezogen. Ook wordt er tijdens het onderzoek via de scoop nog verdoving bijgegeven om een eventuele hoestprikkel te onderdrukken. Er kan weefsel worden weggenomen door hapjes te nemen of te ‘borstelen’. Dit wegnemen van het weefsel kan wat gevoelig zijn en daardoor bijvoorbeeld een hoestprikkel geven. Het kan noodzakelijk zijn om uw luchtwegen te spoelen. Er wordt dan vocht via de scoop in de long gespoten en weer weggezogen.

Na het onderzoek

- Na ongeveer een uur is de verdoving van de keel uitgewerkt. Dan probeert u eerst een klein slokje water te drinken. Let op dat u zich niet verslikt. Als dit wel het geval is, probeert u het na een half uurtje nog een keer.
- Als het slokje water goed gaat, mag u weer gewoon alles eten en drinken wat u gewend bent.
- Als u sedatie hebt gehad, kunt u wat licht in het hoofd zijn. U mag daarom na het onderzoek niet zelfstandig deelnemen aan het verkeer (auto-, brommer rijden of fietsen, ook niet wandelen). Neem iemand mee als begeleider!
- De keel kan een paar dagen wat gevoelig en geïrriteerd zijn. U kunt ook wat hees zijn. Dit is normaal.
- Na het onderzoek kunt u af en toe, gedurende 2 dagen wat bloederig slijm opgeven. Als er helderrood bloed komt (meer dan een bodem van een kopje) neemt u dan direct contact op met de longpoli, tel.nr. 079-3462883 of SEH. U zegt dan dat u een bronchoscopie heeft ondergaan.

- Als er een spoeling is geweest, kunt u een aantal uren na het onderzoek wat koorts krijgen. Als u koorts krijgt, neem dan Paracetamol in. De koorts is meestal na een dag weer over. Als de koorts langer dan een dag aanhoudt (hoger dan 38 °C), neemt u contact op met het ziekenhuis. U zegt dan dat u een bronchoscopie heeft ondergaan.
- Doe het rustig aan op de dag van het onderzoek. Ga niet meteen weer aan het werk. De dag na het onderzoek kunt u in principe uw gewone dagritme weer opnemen.

Niet vergeten

Vergeet niet uw legitimatiebewijs en medicijnlijst mee te nemen.

Contactgegevens

U kunt met al uw vragen contact opnemen met de longpoli, bereikbaar: (079) 346 2883.

Bij spoed buiten kantooruren, kunt u contact opnemen met de spoedeisende hulp, telefoonnummer: (079) 3462539.

Wat vindt u van deze patiënteninformatie?

Wij horen graag uw mening over deze folder. Wilt u na het lezen enkele vragen beantwoorden? U vindt de vragen via deze link: https://folders.hagaziekenhuis.nl/2228. Dank u wel.

Spreekt u geen of slecht Nederlands?

De informatie in deze folder is belangrijk voor u. Als u moeite heeft met de Nederlandse taal, zorg dan dat u deze folder samen met iemand leest die de informatie voor u vertaalt of uitlegt.

Do you speak Dutch poorly or not at all?

This brochure contains information that is important for you. If you have difficulty understanding Dutch, please read this brochure with someone who can translate or explain the information to you.

Czy Państwa znajomość języka niderlandzkiego jest żadna lub słaba?

Informacje zawarte w tym folderze są ważne dla Państwa. Jeśli język niderlandzki sprawia Państwu trudność, postarajcie się przeczytać informacje zawarte w tym folderze z kimś, kto może Państwu je przetłumaczyć lub objaśnić.

Hollandaca dilini hiç konuşamıyor musunuz veya kötü mü konuşuyorsunuz?

Bu broşürdeki bilgi sizin için önemlidir. Hollandaca dilinde zorlanıyorsanız, bu broşürü, size tercüme edecek ya da açıklayacak biriyle birlikte okuyun.

إذا كنتم لا تتحدثون اللغة الهولندية أو تتحدثونها بشكل سيء إن المعلومات الموجودة في هذا المنشور مهمة بالنسبة لكم. إذا كانت لديكم صعوبة في اللغة الهولندية، فاحرصوا عندئذ على قراءة هذا المنشور مع شخص يترجم المعلومات أو يشرحها لكم.